

EJERCICIO PRÁCTICO (TIPO TEST) PARA LA PROVISIÓN DE **OCHO PLAZAS** DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO C, SUBGRUPO C.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE AUXILIAR, CATEGORÍA RAMA SANITARIA, DENOMINACIÓN **TÉCNICA/O EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA** MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

INSTRUCCIONES PARA LAS/OS ASPIRANTES

1º) El Ejercicio consta de **40 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas**, más **5 preguntas de reserva** para posibles anulaciones, dichas preguntas deberán ser contestadas por las/los aspirantes junto con el resto de las preguntas del cuestionario. La duración del ejercicio será de **50 minutos**.

2º) La hoja de respuestas se cumplimentará con **bolígrafo**, en ningún caso con lápiz o bolígrafo cuya tinta se pueda borrar.

3º) En la casilla DNI/NIE/Id, escriba su DNI/NIE/Pasaporte, **uniendo los puntos** como en el ejemplo de la hoja de respuestas. OMITA TODAS LAS LETRAS que pueda contener. Comience a rellenar por la primera casilla y si el número que escribe tiene menos de ocho cifras, complete a la izquierda con ceros.

EJEMPLO: Si su documento de identificación es **X1234567K**, deberá consignar **01234567**, añadiendo un cero a la izquierda.

4º) Rellene los datos personales que aparecen en la cabecera de la hoja de respuestas y **firmé la cabecera**.

5º) Deberá señalar la respuesta que considere correcta rellenando con un aspa de esquina a esquina el cuadro correspondiente a dicha respuesta correcta, de la hoja de respuestas autocopiativa

Ejemplo:

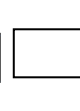
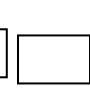
			
---	---	---	---

6º) En el supuesto de que se quiera modificar una respuesta, se anulará ésta mediante el sombreado de dicha respuesta, y se procederá de conformidad con lo establecido en el apartado anterior.

Ejemplo:

			
---	---	---	---

7º) En el supuesto de que quiera dar de nuevo por válida una pregunta anulada, se rodeará con un círculo la que considere correcta. Ejemplo:

			
---	---	---	---

8º) El ejercicio será validado por una máquina, por lo que las respuestas que no cumplan con estas instrucciones no serán validadas, ni podrán ser recurridas.

Ejemplo:



9º) Este Ejercicio será calificado hasta un máximo de **20 puntos**, siendo eliminadas/os las/los aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos. Cada pregunta acertada se computará, con **0,50 puntos**.

10º) Cada tres respuestas erróneas, **se restará una respuesta correcta** del ejercicio. Las preguntas no contestadas **NO restarán** de la puntuación del ejercicio.

EJERCICIO PRÁCTICO

Manuel ha venido a vivir a nuestra residencia hace dos meses debido al reciente fallecimiento de su esposa, procede de una ciudad costera donde ha vivido toda su vida.

Está diagnosticado de EPOC, Diabetes Mellitus Tipo II (insulinodependiente) y Deterioro Cognitivo Leve. Hace cuatro años sufrió un ICTUS que le dejó secuelas físicas (disfagia y deambulación con andador en distancias cortas), tiene antecedentes de HTA y está empezando a tener pérdidas de orina.

En estas últimas semanas presenta insomnio y a veces se muestra muy inquieto queriendo “irse con su mujer”, incluso en una ocasión se ha caído al levantarse de la silla, aun teniendo cerca el andador. Desde ese día utiliza silla de ruedas con frecuencia.

En su Historia de Vida se refleja lo siguiente:

Soy Manuel y nací hace 66 años en Granada. Me he dedicado a la hostelería y he trabajado como camarero y cocinero en un hotel. Mis dos hijas viven en Jaén y han decidido traerme junto a ellas para poder cuidarme mejor.

He sido una persona activa y sociable, pero debido al ICTUS me retiré anticipadamente, aunque una vez recuperada la capacidad de caminar a mi mujer y a mí lo que más nos gustaba era ir a pasear por la playa todas las mañanas. Ahora estoy triste, no quiero conversar ni hablar mucho, no quiero participar en ninguna de las actividades programadas en el centro.

Puedo colaborar en mi aseo y vestido, comer solo, y necesito ayuda para ir al aseo para orinar y defecar. No quiero pañal mientras pueda hacerlo en un WC.

Soy capaz de ponerme en pie, pero no caminar solo porque pierdo el equilibrio.

Juana G. es su personal de referencia y está preocupada por el riesgo de caída y la apatía de Manuel.

CUESTIONARIO

- 1. En el enfoque ACP, ¿qué es lo primero que ha de hacer el personal TCAE si un residente con deterioro cognitivo muestra agitación?**
 - a. Ignorar la conducta para no reforzarla.
 - b. Usar técnicas de redirección y validación emocional.
 - c. Delegar el caso exclusivamente a Enfermería.
 - d. Aplicar métodos de sujeción para evitar riesgos.

2. Si queremos profundizar en el modelo de ACP, ¿qué referentes podemos consultar en Internet?

- a. Fundación Pilares para la Autonomía Personal, de Pilar Rodríguez.
- b. Fundación Matia.
- c. ACP gerontología, de Teresa Martínez.
- d. Todas son correctas.

3. ¿Qué competencia tiene el personal de referencia con respecto al PAI o PPA?

- a. Ninguna, ya que es el equipo técnico el que lo desarrolla e implementa.
- b. Participar en su diseño junto al equipo técnico, además de apoyar y velar por su desarrollo.
- c. Solo colabora en la valoración sanitaria junto a Enfermería.
- d. Leerlo y destruirlo ya que contiene datos íntimos y confidenciales.

4. Como TCAE y personal de referencia de Manuel:

- a. Puedo proponer una actividad significativa para él como servir el agua a sus compañeros de mesa en el comedor.
- b. Puedo preparar su medicación según las indicaciones de Enfermería.
- c. Mi única función es ordenar el armario y tener su ropa al día, con el apoyo de su familia.
- d. Ninguna es correcta.

5. En la Unidad de Convivencia de Manuel, como TCAE y personal de referencia suya, mi competencia NO es:

- a. Establecer cambios en su rutina del aseo, según sus hábitos.
- b. Pedir asesoramiento técnico para facilitar la autonomía en las transferencias de la silla a la cama.
- c. Planificar y facilitar las reuniones de Unidad.
- d. Reunirme con el residente y su familia para realizar su historia de vida.

6. El PAI o PPA:

- a. Es un documento que recoge las valoraciones, preferencias, propuestas de intervención y apoyos personalizados de la persona residente.
- b. Es un plan fijo, que determina las actuaciones e intervenciones a las que el personal tiene que ceñirse para cumplir los deseos del residente.
- c. No es necesario realizarlo en personas totalmente dependientes.
- d. Es realizado solo por el personal de referencia y la coordinadora de unidad.

7. En la unidad de convivencia de Manuel y según el modelo de cuidados ACP, ¿quién desempeña el rol de enlace entre la Unidad de Convivencia y el Centro?

- a. La supervisora de enfermería.
- b. La coordinadora de unidad.
- c. La profesional de referencia.
- d. La familia y el residente.

8. Manuel lleva dos días tocándose la cabeza de forma insistente, gesto que no es habitual en él. La TCAE de turno que se da cuenta, le pregunta y él no contesta. ¿Qué debería hacer?

- a. Obviar esta conducta, no es relevante.
- b. Darle un analgésico porque seguro que le duele la cabeza.
- c. Consultar con su personal de referencia por si este hombre nos quiere decir algo relevante, como por ejemplo utilizar gorra y la ha perdido.
- d. Ponerle unas manoplas en las manos para evitar que se lesione el cuero cabelludo.

9. ¿Qué normativa regula el uso de sujeciones en los centros residenciales y/o sociosanitarios de personas mayores y/o con discapacidad?

- a. Resolución de 13 de enero de 2022 de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.
- b. Instrucción de la Fiscalía General del Estado número 1/2022, de 19 de enero.
- c. No existe nada regulado sobre sujeciones en nuestro país.
- d. El documento técnico elaborado por la Sociedad Española de Geriatria y Gerontología "Cuidado sin sujeciones"

10. Según esta normativa, si lo que pretendemos es que Manuel no se levante de la cama por la noche, ¿qué método de los propuestos a continuación NO es considerado sujeción?

- a. Las barras laterales, si tienen protectores para evitar lesiones.
- b. La cama de Alzheimer a cota cero.
- c. Impedir con mis manos que se levante cada vez que él se quiere incorporar de la cama.
- d. En este caso, todos los métodos elegidos son sujeción física.

11. Si lo que queremos es que Manuel no se caiga durante el día, ¿qué es lo más adecuado que hagamos teniendo en cuenta que es capaz de ponerse en pie, pero no de caminar aún de forma autónoma porque pierde el equilibrio?

- a. Frenarle la silla de ruedas delante de una mesa, solamente mientras acompañamos a otro residente al servicio.
- b. Sentarlo en una silla de ruedas posicional, reclinarla y bascularla para que sea incapaz de levantarse de ella, y así evitar la caída.
- c. Reforzar la vigilancia y ofrecerle alguna actividad significativa para él, que lo mantenga distraído y relajado.
- d. Pedirle a Enfermería nada más verlo inquieto la medicación que tiene prescrita si precisa para evitar que la agitación vaya a más.

12. Los centros residenciales que atienden a personas en el ámbito del SAAD, según la Resolución de 28 de julio de 2022, han de contar con un plan de atención libre de sujeciones, cuya implantación debe ser efectiva:

- a. Antes del 30 de junio de 2025.
- b. El 1 de enero de 2025.
- c. No hay fecha límite para implantarlo.
- d. Una vez sea aprobado por la Dirección del centro.

13. Manuel está triste desde que ingresó, rechaza participar en cualquier intervención o actividad organizada por el centro. Hoy van a realizar un taller de cocina y la terapeuta ocupacional cree que le puede gustar teniendo en cuenta su historia de vida. ¿Qué debemos hacer si queremos hacer un apoyo activo?

- a. No preguntarle si quiere ir porque sabemos que va a rechazar la oferta.
- b. Llevarlo al taller sin preguntarle, seguro que una vez allí se anima.
- c. Explicarle lo que se va a hacer en el taller y pedirle que nos ayude a llevar el vaso batidor, a la vez que lo vamos desplazando con su silla de ruedas hacia la mesa donde se va a preparar la receta. No obstante si persiste en su negativa, respetar su decisión.
- d. Preguntarle una vez y si no quiere respetar su decisión.

14. La sarcopenia se asocia a mayor riesgo de caída. ¿Qué es?

- a. Pérdida de masa ósea.
- b. Pérdida de masa y fuerza muscular.
- c. Rigidez articular.
- d. Deterioro del sistema vestibular.

15. Respecto al estado emocional de Manuel, una buena práctica sería:

- a. Informar a sus hijas de que es normal que esté triste y esperar a que se adapte.
- b. Potenciar una rutina estricta para que se acostumbre al funcionamiento del centro cuanto antes.
- c. Iniciar una escucha activa, explorando con él sus intereses y emociones, favoreciendo espacios significativos.
- d. Animarle a participar en todas las actividades grupales aunque no le apetezca, le vendrá bien distraerse.

16. ¿Cuál sería la práctica más acorde como TCAE de referencia de Manuel?

- a. Reforzar solo sus capacidades físicas, evitando hablar de aspectos emocionales.
- b. Observar cambios y trasladar al equipo posibles intervenciones adaptadas a su historia de vida.
- c. Centrarse únicamente en las tareas de higiene y alimentación.
- d. Hacer que participe siempre en actividades para evitar el aislamiento.

17. En relación a las Unidades de Convivencia, es correcto:

- a. Cambiar a las personas residentes de Unidades de Convivencia si se quejan.
- b. Evitar personal fijo para que todos conozcan a todos los residentes.
- c. Fomentar las relaciones estables entre personal y residentes, respetando los vínculos que se generen.
- d. Organizar la Unidad de Convivencia por niveles de dependencia únicamente.

18. Sabemos que a Manuel le gustaba pasear con su mujer ¿Que medida sería más adecuada teniendo en cuenta su preferencia?

- a. Evitar hablar del tema porque puede ponerlo más triste.
- b. Animarlo a estar solo para que mantenga su independencia.
- c. Proponerle paseos significativos acompañado, si es posible, en un entorno agradable.
- d. Incluirlo en un taller de estimulación cognitiva para distraerlo

19.Cuál de las siguientes afirmaciones supone asumir un buen rol como TCAE de referencia:

- a. Defender siempre al residente, de posibles actitudes o conductas de riesgo.
- b. Ser una vía de comunicación directa, fluida y colaborativa entre la familia y las necesidades del residente, incluidas las emocionales.
- c. Fundamentalmente derivar al personal médico o de enfermería para su valoración.
- d. Ninguna es correcta.

20. ¿Cuál de las siguientes acciones vulnera la intimidad de Manuel?

- a. Hablar de su estado de ánimo con sus hijas en un despacho privado.
- b. Comentar con otro residente que Manuel está deprimido porque enviudó.
- c. Anotar en los seguimientos y la plataforma de comunicación interna del Centro que Manuel no ha querido participar en la actividad organizada porque se encontraba desganado.
- d. Preguntar a Manuel si quiere acompañamiento en los paseos programados en su Plan de Cuidados y reflejarlo en este.

21. ¿Qué principios éticos deben guiar la atención de nuestros residentes en un centro para personas como Manuel?

- a. Autonomía, Dignidad y Confidencialidad.
- b. Beneficiencia y No maleficiencia.
- c. Justicia e Individualidad.
- d. Todas son correctas

22. ¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor una conducta adecuada cuando un/a TCAE se comunica con un residente en un Centro como el de Manuel?

- a. Usar diminutivos cariñosos (cariño, abuelete, niña, etc.) y hablar en tono infantil para que se sienta más cómodo y protegido.
- b. Hablar con rapidez para agilizar el trabajo, sin mirar directamente a los ojos para no incomodar.
- c. Dirigirse al residente con un tono cálido, mirándole a los ojos, con respeto, empatía y sin transmitir lástima o rechazo.
- d. Evitar el contacto físico o emocional para mantener una distancia profesional y no implicarse demasiado.

23. ¿Cuál de las siguientes conductas representa una mala práctica durante la atención directa cuando aseamos a residentes con dependencia?

- a. Hablar con otra compañera sobre asuntos personales, ya que el residente no se entera.
- b. Explicarle con delicadeza lo que vamos a hacer, pidiendo su colaboración y observando sus reacciones.
- c. Mantener un ambiente tranquilo, respetando su intimidad, y centrándonos en la tarea y en su bienestar.
- d. Ajustar nuestros gestos, palabras y tono para que la persona se sienta cómoda y segura en todo momento.

24. ¿Cuál de las siguientes conductas puede considerarse una forma de maltrato?

- a. Decir que se aguante o que “se haga pipí en el pañal” porque ya va a entrar el siguiente turno.
- b. Acompañarla al baño cuando lo solicita, aunque no esté previsto en el horario.
- c. Esperar su respuesta con paciencia cuando le preguntamos que desea hacer.
- d. Respetar que no quiera hablar en un momento determinado.

25. ¿Qué debemos evitar cuando utilizamos el modelo de Atención Centrada en la Persona?

- a. Tratar a todas las personas por igual.
- b. Prestar apoyos personalizados
- c. Promover la interacción de la persona con el entorno, con otras personas y con la comunidad proporcionándole experiencias significativas
- d. Todas son correctas.

26. ¿Cuál de las siguientes lesiones que se exponen están relacionadas con la dependencia ?

- a. Lesiones por presión.
- b. Lesiones cutáneas asociadas a la humedad.
- c. Lesiones por fricción.
- d. Todas son correctas.

27. Si Manuel utilizara pañal durante el día y/o la noche, el uso del doble pañal: (indica lo correcto)

- a. Disminuye la posibilidad de infecciones.
- b. Se puede considerar hasta un signo de maltrato.
- c. No aumenta la sensación de humedad y calor.
- d. Las propias casas comerciales lo aconsejan porque los absorbentes se pueden perforar.

28. Algunos de los factores que contribuyen a la aparición de úlceras por presión, son:

- a. Presión constante, inmovilidad, una dieta rica en nutrientes.
- b. Inmovilidad, fracturas o lesiones óseas, edad avanzada.
- c. Presión variable, una dieta pobre en nutrientes, incontinencia.
- d. Diabetes, deshidratación, presión variable.

29. Manuel anda con ayuda de un andador. Indique cuál de las siguientes escalas usaríamos para valorar el riesgo de caídas.

- a. Escala de Braden.
- b. Escala de Norton.
- c. Escala de Barthel.
- d. Escala de Downton.

30. Manuel está pasando por un duelo. El orden de las etapas del duelo, según Kübler-Ross, es:

- a. Negociación, ira, negación, aceptación y depresión.
- b. Negación, depresión y aceptación.
- c. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación.
- d. Negociación, aceptación, depresión, ira y negación.

31. El equipo interdisciplinar trabaja con Manuel para mejorar su calidad de vida, teniendo siempre presente los principios fundamentales bioéticos. ¿Qué principio de la Bioética hace referencia a minimizar la posibilidad de realizar un daño o un perjuicio Innecesario cuando una actuación no está adecuadamente compensada con los Beneficios que ésta pueda tener?

- a. No maleficencia.
- b. Beneficencia.
- c. Autonomía.
- d. Justicia.

32. Con respecto al riesgo de caídas. Señale cuál de las siguientes NO es una causa intrínseca:

- a. Tipo de calzado.
- b. Problemas o deformidades de los pies.
- c. Anomalías de la marcha.
- d. Deterioro cognitivo.

33. ¿Qué se debe hacer para prevenir la aparición de úlceras por presión en los talones si estuviera encamado?

- a. Aplicar dispositivos de descarga.
- b. Realizar masajes en la zona.
- c. Aplicar talco en zonas húmedas.
- d. Colocar directamente sobre el colchón sin protección.

34. ¿Qué actuación es correcta en una persona como Manuel con piel intacta pero con riesgo de desarrollar UPP?

- a. Limpiar con agua oxigenada.
- b. Usar alcohol de romero.
- c. Cubrir con apósitos adhesivos.
- d. Aplicar ácidos grasos hiperoxigenados

35. ¿Qué tipo de úlcera por presión se caracteriza por eritema que no palidece al presionar?

- a. Estadio II.
- b. Estadio III.
- c. Estadio IV.
- d. Estadio I.

36. ¿Qué aspecto NO se valora en la escala de Braden?

- a. Percepción sensorial.
- b. Nutrición.
- c. Estado mental.
- d. Movilidad.

37. ¿Cuál es el primer signo de alarma en la aparición de una úlcera por presión?

- a. Flictena.
- b. Edema.
- c. Ligera erosión de la piel.
- d. Eritema que no cede al retirar la presión.

38. ¿Qué medida favorece el autocuidado de la persona mayor con deterioro funcional leve?

- a. Imponer un horario estricto.
- b. Evitar que tome decisiones.
- c. Realizar todas las tareas por él.
- d. Respetar su ritmo y ayudar solo si es necesario.

39. ¿Qué acción debe realizar el personal TCAE para favorecer el bienestar psicosocial de una persona anciana?

- a. Fomentar la comunicación y el vínculo emocional.
- b. Limitar el contacto social.
- c. Reforzar el aislamiento.
- d. Evitar temas personales.

40. ¿Qué recurso es adecuado para valorar el riesgo de caídas en la persona mayor?

- a. Escala de Apgar.
- b. Índice de Charlson.
- c. Escala de Morse.
- d. Escala Norton.

PREGUNTAS DE RESERVA

41. ¿Cuál de las siguientes escalas se utiliza específicamente para valorar el riesgo de desarrollar úlceras por presión?

- a. Índice de Barthel.
- b. Escala de Braden.
- c. Escala de Pfeiffer.
- d. Test de Zarit.

42. Respecto a la clasificación de las úlceras por presión, ¿a qué categoría corresponde una lesión caracterizada por pérdida parcial del espesor de la piel que se presenta como una úlcera abierta poco profunda con un lecho de la herida rojo-rosado, sin esfacelos?

- a. Categoría I.
- b. Categoría II.
- c. Categoría III.
- d. Categoría IV.

43. En la atención a una persona encamada, ¿cuál de las siguientes actuaciones del TCAE contribuyen al fomento del autocuidado?

- a. Realizar todas las actividades básicas por el paciente para evitarle esfuerzos.
- b. Informar exclusivamente a los familiares sobre los cuidados, para no preocupar al paciente.
- c. Proporcionar ayuda parcial en las actividades que no pueda realizar por sí mismo, facilitando su participación activa en aquellas que conserve capacidad.
- d. Evitar el uso de ayudas técnicas para favorecer el esfuerzo y mejorar su capacidad funcional.

44. ¿Cuál de los siguientes cambios fisiológicos es característico del envejecimiento en el sistema respiratorio?

- a. Aumento de la capacidad vital.
- b. Incremento de la eficacia de la tos.
- c. Disminución de la elasticidad pulmonar.
- d. Mayor capacidad de adaptación al ejercicio físico.

45. Entre los síndromes geriátricos más frecuentes, ¿cuál se caracteriza por una alteración aguda y fluctuante del estado mental con alteración de la atención y del nivel de conciencia?

- a. Demencia senil.
- b. Síndrome confusional agudo o delirium.
- c. Depresión mayor.
- d. Síndrome de fragilidad.

ANUNCIO

TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA PROVISIÓN DE **OCHO PLAZAS** DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA, PERTENECIENTES AL GRUPO C, SUBGRUPO C.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE AUXILIAR, CATEGORÍA RAMA SANITARIA, DENOMINACIÓN **TÉCNICA/O EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA** MEDIANTE EL SISTEMA DE **OPOSICIÓN LIBRE**.

(BOP núm. 137, de 15-07-2024)

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS

Pregunta	Respuesta Correcta	Pregunta	Respuesta Correcta
1	B	26	D
2	D	27	B
3	B	28	B
4	A	29	D
5	C	30	C
6	A	31	A
7	B	32	A
8	C	33	A
9	B	34	D
10	B	35	D
11	C	36	C
12	A	37	D
13	C	38	D
14	B	39	A
15	C	40	C
16	B	41 (Reserva)	B
17	C	42 (Reserva)	B
18	C	43 (Reserva)	C
19	B	44 (Reserva)	C
20	B	45 (Reserva)	B
21	D		
22	C		
23	A		
24	A		
25	A		

De conformidad con lo establecido en la Base Séptima de la convocatoria, las/os aspirantes disponen de **un plazo de 5 días hábiles**, a partir del día siguiente al de la publicación de esta plantilla en la Sede Electrónica (Tablón de Anuncios) de la Diputación Provincial de Jaén, a los efectos de que los mismos formulen las alegaciones/reclamaciones que deberán ser resueltas por el tribunal antes del comienzo del segundo ejercicio.

Url de Verificación: <https://verifirma.dipujaen.es/code/DfK4lxkFTc+iYM0bPaLo6w==>

FIRMADO POR	MARIETA ORTEGA RAMIREZ - LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL	FECHA Y HORA	23/06/2025 12:46:33
FIRMADO POR	MARÍA DOLORES DE LA CÁMARA CASTELLANO - LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL	FECHA Y HORA	23/06/2025 12:44:57
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	DfK4lxkFTc+iYM0bPaLo6w==	EV00XD7F
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		

